

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cognitive Failures Questionnaire — Cuestionario de Fallos Cognitivos (traducido también como "Escala de autoevaluación del Funcionamiento Cognitivo") (CFQ; registrado en el catálogo de este proyecto como CFQ-Fallos)

Eje V • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 (actualizado) • Estado: ficha documental, no manual — NOTA DE SIGLA (1): el archivo de origen local estaba etiquetado 'CFSS_Scale.pdf', pero el documento real es el Cognitive Failures Questionnaire de Broadbent et al. (1982). NOTA DE SIGLA (2): dentro de este proyecto existe una familia distinta en Eje II con la misma sigla 'CFQ' (Cognitive Fusion Questionnaire, instrumento ACT, no relacionado); para evitar la colisión esta familia se registró como 'CFQ-Fallos'. ACTUALIZACIÓN 2026-08-10: el Protocolo.pdf se reemplazó por una versión completa de 25 ítems (ver más abajo); la versión anterior, truncada a 17 ítems, quedó archivada en esta misma carpeta como Protocolo_17items_truncado_archivo.pdf.

1. Identificación

Familia / sigla	CFQ-Fallos (nombre en la literatura científica: CFQ — ver nota de sigla en el encabezado de esta ficha sobre la colisión con Eje II/CFQ)
Nombre completo	Cognitive Failures Questionnaire — Cuestionario de Fallos Cognitivos (traducido también como "Escala de autoevaluación del Funcionamiento Cognitivo")
Versión / edición	Versión española traducida y adaptada por García Martínez y Sánchez-Cánovas, publicada en Análisis y Modificación de Conducta (1991), Vol. 20, Nº 73: "Adaptación del Cuestionario de Fallos Cognitivos de Broadbent, Cooper, Fitzgerald y Parkes (CFQ)". Nota: algunas fuentes secundarias citan el año de esta adaptación como 1994; la fuente primaria localizada (revista) indica 1991 — se reporta esta discrepancia explícitamente.
Idioma	Español (España).
Autores (original)	Broadbent, D. E., Cooper, P. F., Fitzgerald, P., & Parkes, K. R. (originales). Adaptación española:

	García Martínez, J., & Sánchez-Cánovas, J.
Año (original / adaptación)	1982 (original, British Journal of Clinical Psychology); 1991 (adaptación española, ver nota sobre discrepancia de año en fuentes secundarias).

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	Eje V — Funcionamiento cognitivo y neuropsicológico
Etiquetas	Fallos cognitivos cotidianos; metamemoria; atención; control de la acción; autoinforme.
Pregunta clínica que responde	¿Hay variables cognitivas para explorar o derivar?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: Fallos cognitivos cotidianos de tipo mnésico, atencional y de control del pensamiento/acción, bajo el supuesto teórico de un factor común de labilidad cognitiva (curso de la acción no automatizado que no se ajusta a la intención, según la teoría de Reason).

Finalidad: Autoinforme de metamemoria/fallos cognitivos cotidianos; explorar susceptibilidad a fallos atencionales, mnésicos y de control, y su asociación con estrés y ansiedad.

Usos apropiados:

- Cribado e investigación de fallos cognitivos cotidianos autopercibidos (memoria, atención, control de la acción).
- Estudio de la susceptibilidad al estrés (uso original de los autores del CFQ).
- Complemento a otros cuestionarios de metamemoria (p. ej. MFE, ya presente en este acervo) dentro de una evaluación multimétodo.

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico de deterioro cognitivo o de cualquier condición neurológica: el estudio de adaptación española encontró que el CFQ NO correlaciona de forma significativa con pruebas objetivas de memoria (validez frente a pruebas de ejecución psicométrica muy baja).
- Sustituto de pruebas objetivas de memoria, atención o funciones ejecutivas.

- Uso como prueba de rendimiento mnésico: los propios autores originales y el estudio español concluyen que es un pobre predictor de la capacidad de ejecución de memoria.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos jóvenes y personas mayores. Estudio de adaptación española: 188 jóvenes (estudiantes de BUP/COU/3º de Psicología, Valencia) y 164 personas mayores (centros de jubilados de la Comunidad Valenciana); muestra total N=352.
Contexto de aplicación	Investigación, clínico (como medida de metamemoria/susceptibilidad al estrés), geriatría.
Informante	Autoinforme (existe una versión reducida de 8 ítems para informante, desarrollada por los autores originales, no incluida en este acervo).
Modalidad de administración	Papel y lápiz; individual o colectivo.

5. Estructura y administración

Número de ítems	CORREGIDO 2026-08-10 (segunda vez): se sustituyó el Protocolo.pdf por una versión completa localizada en el propio acervo del proyecto (Eje II/CFQ/Protocolo.pdf, mal ubicada allí por colisión de sigla — ver Fuente_y_uso.md). La versión completa contiene 25 ítems (verificado por conteo directo), coincidiendo con el CFQ estándar de la literatura (Broadbent et al., 1982; adaptación española García Martínez y Sánchez-Cánovas, 1991). La versión anterior de 17 ítems (truncada) queda archivada en esta carpeta como Protocolo_17items_truncado_archivo.pdf, ya no es el protocolo activo.
Periodo temporal de referencia	Últimos 6 meses (frecuencia relativa de cada fallo durante el último medio año).
Formato de respuesta	CORREGIDO 2026-08-10 (segunda vez): la nueva versión completa del protocolo usa escala de 5 puntos DESCENDENTE: 1 = Muy a menudo, 2 = Bastantes veces, 3 = Ocasionalmente, 4 = Muy rara vez, 5 =

	Nunca (a mayor puntuación, MENOS fallos) — esta es la convención coincidente con el estudio de adaptación española citado (García Martínez y Sánchez-Cánovas, 1991). Ya NO aplica la advertencia de la versión anterior (17 ítems, escala 0-4 ascendente); esa versión quedó archivada y no debe usarse.
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 5-10 minutos).

6. Dimensiones y puntuaciones

El estudio original (Broadbent et al., 1982) defiende un factor general único (alta homogeneidad, sin subdivisión clara por tipo de fallo). El estudio de adaptación española, imponiendo una estructura de contenido racional sobre la muestra total (N=352), identificó tres subescalas: Memoria (10 ítems), Atención (8 ítems) y Control de la acción/pensamiento (7 ítems), que suman los 25 ítems totales. La estructura factorial exploratoria resultó inestable entre submuestras (7-8 factores minoritarios además del factor general), por lo que se recomienda priorizar la puntuación total o las 3 subescalas de contenido racional antes que factores exploratorios específicos de una sola muestra.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma de los 25 ítems del Protocolo.pdf vigente (escala 1-5 descendente, 1=Muy a menudo...5=Nunca). Los baremos de García Martínez y Sánchez-Cánovas (1991) citados en la sección de evidencia psicométrica son directamente aplicables a esta versión completa, sin necesidad de la advertencia de discrepancia que aplicaba a la versión truncada anterior.
Ítems invertidos	No se identificaron ítems inversos en los 17 ítems presentes en el protocolo local (todos describen fallos, formulados en sentido positivo).
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible	25-125 (25 ítems, escala 1-5), coincidente con el rango reportado en la literatura de adaptación española para la versión completa del CFQ.

Puntos de corte	No se localizaron puntos de corte clínicos de consenso — no verificado, no usar para decisiones diagnósticas.
------------------------	---

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

García Martínez, J., & Sánchez-Cánovas, J. (1991). Adaptación del Cuestionario de Fallos Cognitivos de Broadbent, Cooper, Fitzgerald y Parkes (CFQ). *Análisis y Modificación de Conducta*, 20(73), 727-750. Muestra: 188 jóvenes (Valencia/Villena) + 164 personas mayores (clubes de jubilados de la Comunidad Valenciana), N total = 352, España. Fiabilidad: alfa de Cronbach ≈ 0.84 en jóvenes y ≈ 0.80 en mayores (cifras de fuentes secundarias) — en el artículo original completo los coeficientes reportados en tabla son: jóvenes $\alpha \approx .840$, mayores y muestra total con valores algo menores debido a la extensión reducida de las subescalas; fiabilidad dos-mitades y consistencia interna calificadas como 'muy buenas' por los autores, comparables al estudio original de Broadbent ($\alpha = .890$). Validez externa: el CFQ NO correlacionó significativamente con pruebas objetivas de memoria (Escala de Memoria de Wechsler, Test de Retención Visual de Benton, RBMT), pero sí con otros cuestionarios de metamemoria (MFE) y con medidas de ansiedad (EPQ-N, STAI-R), replicando el patrón del estudio original de Broadbent et al. (1982). Sensibilidad a la edad: se hallaron diferencias significativas entre jóvenes y mayores (ANOVA, $p = .020$); los mayores reportaron más fallos de memoria pero menos fallos de atención/control que los jóvenes.

9. Adaptación cultural y norma local

Adaptación y validación en población española (García Martínez & Sánchez-Cánovas). No se localizó una adaptación específica para Latinoamérica con normas propias en la búsqueda realizada — no verificado.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- El propio estudio de adaptación española concluye que el CFQ tiene buena fiabilidad pero validez limitada frente a pruebas objetivas de memoria; no debe usarse como prueba de rendimiento mnésico.
- Es una medida de metamemoria/autopercepción, con posible contaminación por ansiedad y estrés (fuerte asociación con medidas de ansiedad rasgo).
- No sustituye evaluación neuropsicológica objetiva ni el juicio clínico profesional.

- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Confirmar siempre la dirección/codificación de la escala de respuesta antes de puntuar (ver advertencia en 'Formato de respuesta'), dado el riesgo de error de interpretación.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El CFQ original (Broadbent et al., 1982) fue publicado en el British Journal of Clinical Psychology; es ampliamente reproducido en la literatura científica internacional con fines de investigación (no se ha identificado una editorial comercial que restrinja su uso académico). La adaptación española (García Martínez & Sánchez-Cánovas, 1991) fue publicada en Análisis y Modificación de Conducta, incluyendo el cuestionario completo en un apéndice de acceso académico. El Protocolo.pdf de este acervo es un escaneo de un documento de circulación académica/clínica (ya presente en el acervo local del proyecto, etiquetado originalmente como 'CFSS_Scale.pdf'), identificado por OCR y contrastado con las fuentes citadas. Verificar condiciones de reproducción con los titulares/editoriales antes de cualquier uso comercial o redistribución masiva — no verificado con certeza absoluta.

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Broadbent, D. E., Cooper, P. F., FitzGerald, P., & Parkes, K. R. (1982). The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) and its correlates. British Journal of Clinical Psychology, 21, 1-16. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1982.tb01421.x>

García Martínez, J., & Sánchez-Cánovas, J. (1991). Adaptación del Cuestionario de Fallos Cognitivos de Broadbent, Cooper, Fitzgerald y Parkes (CFQ). Análisis y Modificación de Conducta, 20(73), 727-750. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7075559.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (versión completa de 25 ítems, localizada en el propio acervo del proyecto — Eje II/CFQ/Protocolo.pdf, reubicada aquí el 2026-08-10 por ser el documento correcto; ver Fuente_y_uso.md para el detalle de la reubicación).
----------------------------	--

	Protocolo_17items_truncado_archivo.pdf (versión anterior, archivada, ya no activa). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Ficha actualizada el 2026-08-10 tras localizar una versión completa (25 ítems) del mismo protocolo dentro del propio acervo del proyecto, que estaba mal ubicada en Eje II/CFQ por una colisión de sigla con el Cognitive Fusion Questionnaire (instrumento ACT no relacionado). Se sustituyó el protocolo truncado de 17 ítems por esta versión completa. Requiere revisión humana antes de uso clínico formal.

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0